

Complicaciones infecciosas del puerperio

1. Introducción y relevancia clínica

Las **infecciones puerperales** son un grupo de patologías infecciosas que ocurren en el **posparto hasta los 42 días después del parto o aborto**, y constituyen una **causa relevante de morbilidad y mortalidad materna**, especialmente en países en desarrollo.

La causa más frecuente es la **endometritis puerperal**, seguida por **mastitis, infección de herida quirúrgica o episiotomía, y tromboflebitis pélvica séptica**.

En Chile, gracias al control obstétrico y profilaxis antibiótica sistemática, la incidencia ha disminuido, pero **sigue siendo un tema central en la evaluación clínica del EUNACOM**.

□ EUNACOM clásico:

“Puerpera de 3 días post cesárea con fiebre 38,5°C y loquios fétidos → diagnóstico: endometritis puerperal.”

2. Fisiopatología y bases conceptuales

Durante el parto o cesárea, la **barrera cervical y endometrial se altera**, facilitando la ascensión bacteriana desde la flora vaginal o intestinal hacia el útero y anexos.

Factores como la **presencia de sangre, tejido necrótico y manipulación obstétrica** favorecen la proliferación bacteriana.

El origen más común es **polimicrobiano**, destacando:

Microorganismo	Frecuencia / tipo
<i>Escherichia coli</i>	Flora intestinal
<i>Streptococcus grupo B</i>	Vaginal
<i>Staphylococcus aureus</i>	Cutáneo

<i>Enterococcus</i> spp.	Hospitalario
--------------------------	--------------

<i>Bacteroides</i> spp. y <i>Peptostreptococcus</i>	Anaerobios comunes
--	-----------------------

3. Factores de riesgo

Maternos	Obstétricos	Iatrogénicos
Anemia, obesidad, diabetes	Cesárea, parto prolongado, RPM >18 h	Examen vaginal repetido, instrumentación
Desnutrición, inmunosupresión	Hemorragia posparto	Ausencia de profilaxis antibiótica
Infección previa	Retención de restos placentarios	Falta de asepsia en parto domiciliario

☐ La cesárea multiplica por 5–10 veces el riesgo de infección uterina frente al parto vaginal.

4. Clasificación clínica de las infecciones puerperales

Nivel anatómico	Patología principal	Frecuencia
Endometrio / miometrio	Endometritis puerperal	Más común
Mamas	Mastitis o absceso mamario	Frecuente

Heridas quirúrgicas / perineales	Infección de herida de cesárea o episiotomía	Variable
Venas pélvicas	Tromboflebitis pélvica séptica	Menos frecuente, pero grave

5. Endometritis puerperal

Definición

Infección del endometrio (y a veces miometrio) que aparece dentro de los primeros **10 días postparto o postaborto**.

Etiología

Flora polimicrobiana: *E. coli*, *Streptococcus grupo B*, *Bacteroides*, *Peptostreptococcus*.

Factores predisponentes

- Cesárea (especialmente si no recibió antibiótico profiláctico).
- Trabajo de parto prolongado o con múltiples tactos.
- Ruptura de membranas >18 h.
- Retención de restos placentarios.

Clínica característica

- Fiebre >38°C, generalmente entre el 2°–5° día.
- **Loquios fétidos o purulentos.**
- Dolor hipogástrico.
- Útero blando, doloroso, mal involucionado.
- Taquicardia y malestar general.

Diagnóstico

- Clínico principalmente.
- Hemograma: leucocitosis con desviación a la izquierda.
- Ecografía pélvica: descartar restos retenidos o absceso.
- Cultivo de loquios o hemocultivos en casos graves.

Tratamiento (según MINSAL / Guía Perinatal 2023)

- Hospitalización.
- Antibióticos EV de amplio espectro hasta 48 h afebril:
 - Clindamicina 900 mg EV cada 8 h + Gentamicina 5 mg/kg EV cada 24 h.
 - Alternativa: Ampicilina + Metronidazol + Gentamicina.
- Uterotónicos (oxitocina) para favorecer drenaje.
- Evaluar restos uterinos (eco). Si sospecha → legrado uterino diferido.

□ En EUNACOM, esta tríada es diagnóstica: fiebre + loquios fétidos + útero blando → endometritis puerperal.

6. Infección de herida quirúrgica o episiotomía

Factores de riesgo

- Cesárea urgente, obesidad, anemia, diabetes, técnica inadecuada, hematoma perineal.

Clínica

- Dolor localizado, eritema, secreción purulenta o dehiscencia de sutura.
- Fiebre moderada, malestar general.

Diagnóstico

- Clínico.
- Cultivo de secreción si supuración importante.

Tratamiento

- Retirar puntos comprometidos.
- Drenaje del absceso o material purulento.
- Curaciones locales con solución salina.
- Antibióticos dirigidos (ej. **Cefazolina o Amoxicilina/clavulánico EV**).
- En casos graves: hospitalización y cobertura para *S. aureus* resistente.

☐ Si hay dehiscencia perineal amplia o celulitis, **no resuturar** hasta resolución completa de la infección.

7. Mastitis puerperal

Definición

Inflamación infecciosa del tejido mamario, habitualmente entre la **2ª y 4ª semana del puerperio**.

Etiología

- *Staphylococcus aureus* (más frecuente).
- Infección suele originarse por fisura del pezón → entrada de bacterias.

Clínica

- Dolor mamario, enrojecimiento, calor local.
- Fiebre >38°C, escalofríos, malestar general.
- Ganglios axilares sensibles.

Diagnóstico

- Clínico.
- Ecografía mamaria si sospecha absceso.

Tratamiento

- Continuar lactancia (no suspender, excepto en absceso con drenaje).
- Antibióticos por 10–14 días:
 - **Cloxacilina o Dicloxacilina 500 mg VO cada 6 h.**
 - Alternativa: **Cefalexina o Clindamicina** si alergia a penicilinas.
- Antiinflamatorios, analgésicos y apoyo local (compresas tibias, sostén).
- Si absceso: drenaje quirúrgico + cultivo.

□ EUNACOM clásico: “Paciente con dolor y fiebre, eritema en mama derecha, 15 días postparto → mastitis puerperal por *S. aureus*, continuar lactancia.”

8. Tromboflebitis pélvica séptica

Definición

Infección y trombosis de venas ováricas o uterinas, generalmente tras cesárea o endometritis no tratada.

Clínica

- Fiebre persistente a pesar de antibióticos.
- Dolor abdominal o en flanco derecho.
- Masa dolorosa o signo de defensa localizada.
- Hemocultivos positivos en algunos casos.

Diagnóstico

- Clínico, apoyado por ecografía Doppler o TAC pélvico (trombo séptico).

Tratamiento

- Antibióticos EV de amplio espectro +
- **Heparina de bajo peso molecular** (HBPM) durante 7–10 días.
- Continuar antibióticos hasta 48–72 h afebril.

9. Profilaxis de infecciones puerperales

Medida	Recomendación
Profilaxis antibiótica en cesárea	Cefazolina 2 g EV 30–60 min antes de incisión
Asepsia obstétrica	Lavado de manos, técnica estéril, tactos mínimos
Evitar tactos vaginales innecesarios	Disminuye contaminación ascendente
Vigilancia postparto	Control diario de temperatura y loquios
Oxigenación y buena contracción uterina	Evita retención de loquios
Educación postalta	Signos de alarma: fiebre, dolor, sangrado, secreción fétida

10. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Fiebre puerperal:** $\geq 38^{\circ}\text{C}$ en las primeras 10 días postparto (excepto primeras 24 h).
2. **Endometritis puerperal:** loquios fétidos + fiebre + útero blando $\rightarrow$ antibióticos EV.
3. **Mastitis:** *S. aureus* $\rightarrow$ Cloxacilina; continuar lactancia.
4. **Profilaxis antibiótica cesárea:** Cefazolina 2 g EV antes de incisión.
5. **Fiebre persistente con antibióticos** $\rightarrow$ **sospechar tromboflebitis séptica.**



Errores comunes

- Iniciar antibióticos por vía oral en endometritis (debe ser EV).
- Suspendir lactancia innecesariamente en mastitis.
- No descartar restos retenidos en endometritis refractaria.
- Ignorar profilaxis antibiótica en cesárea.
- No hospitalizar fiebre puerperal moderada.

11. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Infecciones puerperales** = infecciones ≤ 42 días postparto, más comúnmente **endometritis**.
2. **Fiebre + loquios fétidos + útero blando** $\rightarrow$ **endometritis puerperal**.
3. **Tratamiento:** Clindamicina + Gentamicina EV hasta 48 h afebril.
4. **Mastitis:** *S. aureus*, Cloxacilina, continuar lactancia.
5. **Profilaxis cesárea:** Cefazolina preincisión.
6. **Fiebre persistente a pesar de antibióticos** $\rightarrow$ **tromboflebitis pélvica séptica**.
7. **Prevención:** asepsia, tactos mínimos, oxitocina posparto, control diario.